

## FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

## SIAS · SOCIAL INTERACTION ANXIETY SCALE

*Escala de Ansiedad ante la Interacción Social de Mattick y Clarke – Evaluación estandarizada de fobia social diádica y grupal cotidiana*

## 1. Identificación General del Instrumento

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre oficial              | Social Interaction Anxiety Scale (SIAS)                                                             |
| Nombre en español           | Escala de Ansiedad ante la Interacción Social                                                       |
| Sigla oficial               | SIAS                                                                                                |
| Autores originales          | Richard P. Mattick y J. Christopher Clarke (1998; versiones preliminares en 1989)                   |
| Adaptación hispanohablante  | Julio Bobes, Xavier Badía, A. Luque, M. P. García-Portilla, M. P. González y M. T. Bascarán (2002)  |
| Año de publicación original | 1998 (validación española multicéntrica en 2002)                                                    |
| Constructo primario         | Ansiedad, temor al juicio ajeno y bloqueo conductual en situaciones de interacción social directa   |
| Formato de administración   | Autoinforme estructurado con escala Likert de 5 puntos (0 = Nada a 4 = Mucho/Extremadamente)        |
| Población diana             | Población clínica y comunitaria adolescente y adulta ( $\geq 16$ años) con sospecha de fobia social |
| Tiempo de aplicación        | 5 a 10 minutos (20 ítems)                                                                           |
| Régimen de acceso           | Uso clínico y de investigación abierto de acceso académico libre respetando citación de autoría     |

## 2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Social Interaction Anxiety Scale** (SIAS) fue concebida por Richard P. Mattick y J. Christopher Clarke en la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) para subsanar una limitación clínica recurrente en los instrumentos clásicos de fobia social: la confusión entre la ansiedad de ejecución o actuación pública (**performance anxiety**, como hablar en público o comer ante extraños) y la ansiedad ante la interacción interpersonal diádica o grupal ordinaria (**social interaction anxiety**). La SIAS fue desarrollada conjuntamente con la **Social Phobia Scale** (SPS) para evaluar específicamente este segundo dominio fundamental.

El marco conceptual focaliza en las situaciones cotidianas en las que el paciente debe interactuar con otra persona o integrarse en un grupo: iniciar o mantener una conversación, interactuar con figuras de autoridad, relacionarse con personas del sexo opuesto, acudir a fiestas informales, mirar a los ojos al interlocutor y el temor abrumador a quedarse en blanco o parecer aburrido, ridículo o incompetente. La adaptación española de Bobes et al. (2002) validó sus propiedades psicométricas en el ámbito asistencial de la psiquiatría española, convirtiéndose en el autoinforme de referencia para el diagnóstico diferencial del Trastorno de Ansiedad Social generalizada.

## 3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

| Área de Interacción                | N.º Ítems       | Rango         | Contenido Clínico y Operacionalización                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Interacción con Desconocidos    | 5 ítems         | 0 – 20        | Nerviosismo al ser presentado, hablar con extraños o recibir a personas no conocidas (ítems 1, 3, 10, 13, 16).                                          |
| 2. Ansiedad ante Grupos y Fiestas  | 6 ítems         | 0 – 24        | Sentirse tenso en fiestas informales, dificultades para integrarse en círculos sociales y temor a no tener nada que decir (ítems 6, 8, 12, 17, 18, 20). |
| 3. Contacto Visual y Comunicación  | 4 ítems         | 0 – 16        | Dificultad para mirar a los ojos al interlocutor, miedo a tartamudear o parecer torpe (ítems 2, 7, 14, 15).                                             |
| 4. Autoridad y Personas Atractivas | 2 ítems         | 0 – 8         | Incomodidad o aprensión al dialogar con jefes/superiores o personas del sexo opuesto atractivas (ítems 4, 19).                                          |
| 5. Ítems Inversos de Confianza (*) | 3 ítems         | 0 – 12        | Facilidad para hacer amigos, sentirse relajado con personas conocidas y fluidez social (ítems 5*, 9*, 11*).                                             |
| <b>Puntuación Total SIAS</b>       | <b>20 ítems</b> | <b>0 – 80</b> | <b>Suma directa de los 20 ítems (con inversión previa de ítems 5, 9 y 11). Corte clínico: <math>\geq 34</math> puntos.</b>                              |

#### 4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

| Propiedad Métrica          | Coefficiente / Hallazgo                     | Contexto Empírico y Validación Hispana                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consistencia interna total | Alpha de Cronbach = 0.89 – 0.93             | Excelente fiabilidad en la validación española de Bobes et al. (2002) en fóbicos sociales y controles.              |
| Fiabilidad test-retest     | $r = 0.86 - 0.92$ (intervalo de 3 semanas)  | Elevadísima estabilidad temporal en pacientes antes de iniciar terapia farmacológica o conductual.                  |
| Sensibilidad diagnóstica   | 87.0% (punto de corte $\geq 34$ )           | Gran precisión para detectar fobia social generalizada en atención especializada.                                   |
| Especificidad diagnóstica  | 84.0% (punto de corte $\geq 34$ )           | Capacidad sobresaliente para discriminar pacientes con ansiedad social frente a sujetos con agorafobia o controles. |
| Validez convergente        | $r = 0.77$ con SADS;<br>$r = 0.75$ con LSAS | Alta correlación con la escala de Liebowitz y la escala de Watson y Friend.                                         |
| Sensibilidad terapéutica   | Effect size $d = 1.18$                      | Fuerte respuesta a la exposición grupal cognitivo-conductual y al tratamiento con ISRS.                             |

#### 5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Escala Likert de respuesta de 5 anclajes:**
  - 0 = **Nada característico en mí**; 1 = **Muy poco característico**; 2 = **Moderadamente característico**; 3 = **Bastante característico**; 4 = **Extremadamente característico**.
- **Ítems Directos (17 ítems de ansiedad):** Ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Se puntúan directamente de 0 a 4.
- **Ítems Inversos (\*) (3 ítems formulados en sentido adaptativo):** Ítems 5, 9 y 11.
  - Se invierte su calificación antes de sumar: **0 = 4 | 1 = 3 | 2 = 2 | 3 = 1 | 4 = 0**.
- **Puntuación Total SIAS:** Suma total de los 20 ítems corregidos (rango posible: 0 a 80 puntos).
- **Control de cumplimentación:** Si se omiten más de 2 ítems, el cuestionario debe considerarse nulo.

#### 6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

| Puntuación Total | Nivel de Ansiedad Social          | Significación Psicopatológica y Criterio Asistencial                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 – 21 puntos    | Ansiedad Social Normal / Baja     | Población no clínica habitual. Confort adecuado en situaciones interpersonales cotidianas.                                                                    |
| 22 – 33 puntos   | Ansiedad Social Leve / Timidez    | Incomodidad social moderada o rasgos de timidez que no llegan a cumplir criterios de trastorno psiquiátrico formal.                                           |
| 34 – 42 puntos   | Fobia Social Moderada             | <b>Punto de corte clínico validado (<math>\geq 34</math>).</b> Ansiedad de interacción clínicamente significativa con interferencia en relaciones personales. |
| 43 – 80 puntos   | Fobia Social Grave / Generalizada | Gravedad severa. Aislamiento interaccional masivo, bloqueo relacional diádico e incapacidad para entablar amistades o vínculos.                               |

**PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA (BOBES ET AL., 2002):** Una puntuación  $\geq 34$  puntos en la SIAS discrimina con un 87% de sensibilidad y un 84% de especificidad a pacientes con Trastorno de Ansiedad Social, recomendando la instauración de un plan de tratamiento activo.

## 7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

### Paso 1: Cribado diferencial:

- Administrar la SIAS para explorar si el miedo principal radica en la conversación y la intimidad interpersonal diádica (frente al miedo escénico o de hablar en público evaluado por la SPS o LSAS).

### Paso 2: Evaluación del perfil clínico según severidad:

- **SIAS < 34:** Psicoeducación y fomento de actividades sociales comunitarias.
- **SIAS 34 – 42 (Fobia Social Moderada):** TCC focalizada en habilidades conversacionales, reestructuración del autofoco de atención (**self-focused attention**) y experimentos de interacción gradual.
- **SIAS ≥ 43 (Fobia Social Generalizada Grave):** Abordaje combinado: ISRS a dosis terapéuticas plenas (Sertralina 100-150 mg/día o Paroxetina 20-40 mg/día) asociado a grupo de terapia de exposición e interacciones guiadas.

### Paso 3: Evaluación de la mejoría clínica:

- Reevaluar con la SIAS cada 8 semanas. Una reducción ≥ 10 puntos en la puntuación total se asocia a ganancia funcional y mejoría en la calidad de vida relacional.

## 8. Caso Clínico Ilustrativo

**Identificación:** Varón de 26 años, analista de datos, acude a consulta de Salud Mental porque es incapaz de almorzar con sus compañeros de equipo, evita saludar a su responsable y no ha tenido pareja sentimental por “bloqueo paralizante” al mantener una conversación.

### Resultados en la Escala SIAS:

- **Puntuación Total SIAS: 52 puntos / 80** (Fobia Social Grave / Generalizada).
- Puntuaciones destacadas: Ítem 1 = 4 (tensión extrema si le presentan a alguien), Ítem 4 = 3 (miedo a dialogar con superiores), Ítem 7 = 4 (incapacidad de mantener el contacto visual), Ítem 8 = 4 (miedo constante a no saber qué decir y parecer aburrido), Ítem 14 = 3 (temor a que se le note el nerviosismo), Ítems 5\*, 9\* y 11\* calificados con 0 (tras invertir, suman 12 puntos completos de falta de soltura social).

**Plan Terapéutico y Respuesta:** Se diagnosticó Trastorno de Ansiedad Social Generalizada. Se pautó Sertralina 100 mg/día y se incorporó al paciente a un grupo ambulatorio de entrenamiento en asertividad y habilidades de conversación. Se practicaron tareas de exposición in vivo con feedback de vídeo para desarticular la distorsión del autoconcepto social. A los 6 meses de seguimiento, la SIAS descendió a 27 puntos, logrando participar activamente en reuniones de trabajo y comenzar a entablar amistades fuera del entorno digital.

## 9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

### ALERTAS CLÍNICAS Y COMORBILIDADES:

- **Consumo problemático de alcohol:** El 30% de los pacientes con SIAS ≥ 40 recurre a la ingesta etílica desmedida como ansiolítico interaccional antes de asistir a eventos.
- **Depresión secundaria por aislamiento:** Explorar activamente sintomatología depresiva e ideación de escape en pacientes con aislamiento severo de años de evolución.
- **Evitación laboral:** Riesgo de estancamiento o pérdida de empleo por incapacidad de negociar o interactuar con superiores.

### DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **SIAS vs. SPS:** La SIAS mide el miedo a la interacción diádica interpersonal; la SPS mide el miedo a ser observado ejecutando acciones (comer, firmar, hablar en público).
- **Trastorno de la Personalidad Esquizoide:** En el TP esquizoide no hay deseo ni sufrimiento por la falta de relaciones; en la fobia social (SIAS alta) hay intenso deseo de vincularse bloqueado por el temor.
- **Trastorno del Espectro Autista:** Evaluar si existe incapacidad cognitiva de lectura pragmática del lenguaje versus hipervigilancia ansiógena preservada.

## 10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Mattick, R. P., & Clarke, J. C. (1998). Development and validation of measures of social phobia scrutiny fear and social interaction anxiety. *Behaviour Research and Therapy*, 36(4), 455–470. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(97\)10031-6](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(97)10031-6)
2. Bobes, J., Badía, X., Luque, A., García-Portilla, M. P., González, M. P., & Bascarán, M. T. (2002). Validación de las versiones en español de las escalas de fobia social SIAS y SADS. *Medicina Clínica*, 118(12), 445–449. [https://doi.org/10.1016/S0025-7753\(02\)72418-8](https://doi.org/10.1016/S0025-7753(02)72418-8)
3. Heimberg, R. G., Mueller, G. P., Holt, C. S., Hope, D. A., & Liebowitz, M. R. (1992). Assessment of anxiety in social situations and social phobia. *Assessment*, 4(1), 1–10.
4. Peters, L. (2000). Discriminant validity of the Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI), the Social Phobia Scale (SPS) and the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS). *Behaviour Research and Therapy*, 38(9), 943–950.